

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		PENGAMBILAN SAMPEL UNTUK PEMERIKSAAN IMS PASIEN WANITA	
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	No. Dokumen 375.39/I-SPO/DIR/VII/2026	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 23 Juli 2026	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Resti Lestantini, M.Kes	
Pengertian	Untuk penegakan diagnosis IMS diperlukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel biologis yang diambil dari genitalia		
Tujuan	Sebagai acuan penerapan pengambilan sampel biologis untuk pemeriksaan IMS pasien wanita		
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 325.4/I-PDM/DIR/IV/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. 2. Pedoman Nasional Penanganan Infeksi Menular Seksual, Jakarta, 2015. 3. Standard Operasional Prosedur Klinik Infeksi Menular Seksual, Departemen Kesehatan- USAID- FHI-ASA, 2007.		
Prosedur	1. Kenakan sarung tangan. 2. Minta pasien untuk berbaring dengan posisi litotomi (menekuk lutut dan membuka tungkai) – posisi seperti waktu melahirkan. 3. Inspeksi genitalia eksterna, amati adanya kelainan atau gangguan (misal: ada kutu, luka /ulkus, benjolan dan duh tubuh) 4. Periksa area labium mayora dan minora, urethral meatus, clitoris, introitus, perineum dan perianal. Amati adanya luka, kutil, dan duh tubuh. 5. Lakukan pemeriksaan dengan spekulum: a. Jika ada ulkus di area introitus vagina, pemeriksaan dengan spekulum ditunda sampai ulkus sembuh b. Celupkan spekulum ke dalam air bersih yang hangat c. Buka labium dengan jari jari tangan kanan. Masukkan jari telunjuk tangan kiri ke dalam vagina secara lembut dan perlahan, tekan ke bawah dan mintalah pasien untuk relaks d. Tangan kanan memegang spekulum, perlahan masukan spekulum dengan posisi miring sekitar 45 derajat dengan arah agak ke bawah. Jika spekulum telah masuk setengah, putar spekulum sehingga posisinya horisontal. e. Setelah masuk semua, buka lah spekulum, perbaiki posisi spekulum secara lembut dan perlahan (ditarik sedikit, digeser sedikit) sampai serviks nampak. Kunci spekulum, setelah serviks tampak cukup jelas. f. Inspeksi serviks. Serviks yang normal berwarna merah muda, berbentuk bundar dan rata/halus. Jika serviks tertutup banyak duh tubuh, bersihkan bagian luar servik dengan lidi kapas. 6. Ambil sediaan Pertama : sampel vagina dengan lidi kapas untuk pemeriksaan sediaan basah NaCl & KOH a. Ambil lidi kapas steril yang pertama b. Bersihkan sekitar mulut serviks/rahim dengan lidi kapas steril kemudian ke fornix posterior dan dinding vagina. c. Slide diletakkan di meja jika tidak ada asisten, jika ada asisten pembuatan preparat dapat dilakukan oleh asisten.		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGAMBILAN SAMPEL UNTUK PEMERIKSAAN IMS PASIEN WANITA		
	No. Dokumen 375.39/I-SPO/DIR/VII/2026	No. Revisi 00	Halaman 2 / 1
	d. Dari lidi kapas pertama ini buatlah apusan berupa dua lingkaran kecil pada sisi kanan dan kiri slide untuk pemeriksaan sediaan basah, olesan jangan terlalu tebal atau tipis. atau masukkan ke dalam tabung yang berisi 1 ml NaCl 0,9%. e. Lakukan pemeriksaan keasaman vagina dengan menempelkan lidi kapas yang telah digunakan untuk mengambil sediaan dari forniks dan dinding vagina pada kertas pH f. Buang lidi kapas yang sudah digunakan ke dalam tempat sampah infeksius 7. Ambil sediaan Kedua : sampel serviks dengan lidi kapas untuk pemeriksaan sediaan kering Gram a. Ambil lidi kapas steril kedua b. Masukkan lidi kapas steril ke dalam saluran endoserviks sedalam 1 – 1.5 cm, putar lidi kapas searah jarum jam 2-3 kali (10-30 detik) untuk dapatkan sampel yang cukup. c. Tarik lidi kapas pelan-pelan tanpa menyentuh dinding vagina. d. Buatlah hapusan pada kaca objek kedua dengan cara menggulirkan lidi kapas dengan berhati-hati untuk dilakukan pengecatan Methylen-Blue atau Gram e. Pembuatan apusan usahakan satu kali jadi. Jika tidak, mulai dari arah yang sama dan tidak boleh bolak-balik arah. f. Apusan jangan terlalu tebal atau terlalu tipis g. Lidi kapas yang sudah terpakai dibuang ke tempat sampah infeksius 8. Lepaskan kunci spekulum dan keluarkan spekulum secara perlahan sambil mengamati dinding vagina, apakah ada ulkus, kutil dan duh tubuh. 9. Saat spekulum sudah di luar tubuh, teteskan KOH ke cairan yang ada di bagian ujung spekulum. Segera identifikasi apakah ada bau amis yang keluar. 10. Masukkan speculum bekas ke dalam ember yang berisi larutan chlorin 0,5%. 11. Lakukan pemeriksaan bimanual: a. Periksa posisi berdiri. b. Oleskan pelumas pada sarung tangan di area jari telunjuk dan jari tengah, masukan kedua jari melalui introitus vagina, secara perlahan c. Raba serviks dan gerakan/goyang kiri kanan sambil amati apakah ada ekspresi sakit pada pasien. d. Letakan tangan kiri di perut bawah, palpasi secara bimanual untuk memperkirakan besar uterus. e. Tangan kiri menekan di kuadran kanan bawah perut dan tangan kanan menekan forniks kanan, lakukan palpasi ovarium kanan. Ulangi prosedur untuk ovarium kiri. 12. Minta pasien untuk memakai pakaiannya kembali. Minta pasien untuk menunggu hasil. 13. Catat semua hasil pemeriksaan dan asal spesimen (lingkari uretra/anus/serviks) pada catatan medis. 14. Bawa ke ruang laboratorium bersama slide dan pastikan semua sudah ada kode yang sama dengan kode catatan medis pasien.		
Unit Terkait	1. Instalasi Rawat Jalan 2. Instalasi Rawat Inap		